O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

A-4: Shox parda, oqsil parda, tomirli parda, to‘r parda va ko‘ruv nervi yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik ishi

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Amaliy mashg‘ulot, 4 soat (160 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda shox parda va kon’yunktivani mahalliy og‘riqsizlantirish, yot jismni olishda ishtirok etish, iridotsiklitli bemorlarni tekshirish, o‘tkir holatda birinchi yordam ko‘rsatish va ko‘z tubini tekshirishga tayyorlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Shox pardani mahalliy og‘riqsizlantirish va yot jismni olish
2. Irit, iridotsiklit, uveitli bemorlarda tekshirish va birinchi yordam
3. Ko‘z tubini tekshirish va to‘r parda, ko‘ruv nervi kasalliklarida parvarish

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Shox pardani mahalliy og‘riqsizlantirish tartibini aytib beradi.
- Yot jismni olish uchun jihozlarni tayyorlaydi va muolajada ishtirok etadi.
- Iridotsiklitli bemorda ko‘rish o‘tkirligini tekshiradi, o‘tkir holatda birinchi yordam ko‘rsatadi.
- Bemorni ko‘z tubini tekshirishga tayyorlaydi.

Tayanch so‘zlar

mahalliy og‘riqsizlantirish, anestetik tomchi, yot jism, flyuoressein, iridotsiklit, atropin, oftalmoskopiya, midriaz, lazer koagulyatsiyasi.

1. Shox pardani mahalliy og‘riqsizlantirish va yot jismni olish

Shox parda va kon’yunktiva juda sezgir bo‘lgani uchun ko‘plab muolajalar oldidan mahalliy og‘riqsizlantirish bajariladi. U tonometriya, yot jism olish, ko‘z yoshi yo‘llarini yuvish, kon’yunktiva ostiga in’yeksiya va ko‘z operatsiyalaridan oldin qo‘llaniladi. Buning uchun shifokor buyurgan anestetik tomchilar, masalan, 0,5% proksimetakain yoki 0,4% oksibuprokain ishlatiladi. Ta’sir 1–2 daqiqada boshlanadi va 15–20 daqiqa davom etadi. Anestetik tomchi faqat muolaja uchun qo‘llaniladi: uni bemorga uyga berish mumkin emas, chunki doimiy ishlatish shox parda epiteliysini shikastlaydi.

Mahalliy og‘riqsizlantirish

Jihozlar: anestetik tomchi, steril pipetka, steril tamponlar

1. Qo‘lni yuving, bemorga muolaja maqsadini tushuntiring.
2. Dori nomini, muddatini, allergiya bor-yo‘qligini aniqlang.
3. Bemorning boshini orqaga egdiring, yuqoriga qarashini so‘rang.
4. Pastki qovoqni tortib, o‘tish burmasiga 1 tomchi anestetik tomizing.
5. 1–2 daqiqa oralatib, buyurilgan bo‘lsa, yana 1–2 marta takrorlang.
6. Bemorga ko‘zini ishqalamaslikni tushuntiring.
7. Muolajadan keyin 20 daqiqa davomida ko‘zni himoya qilishni ayting: sezgirlik kamaygan.

Yot jismlar

Ko‘zga yot jism kirishi eng ko‘p uchraydigan shikoyatlardan biri. Chang, qum, metall zarrachasi, kuya kabi jismlar kon’yunktivada yoki shox pardada to‘xtaydi. Bemor kuchli achishish, yot jism sezgisi, ko‘z yoshlanishi va qovoq qisilishidan shikoyat qiladi. Ko‘zni ishqalash shox pardani tirnaydi, shuning uchun bemorga ko‘zini ishqalamaslik aytiladi. Yot jism pastki o‘tish burmasida yoki yuqori qovoq ostida ko‘p topiladi.

Kon’yunktivadagi yuza yot jismni hamshira olishi mumkin. Pastki qovoq tortiladi yoki yuqori qovoq ag‘dariladi, yot jism steril fiziologik eritma bilan namlangan paxta tampon yordamida olib tashlanadi, keyin antiseptik tomchi tomiziladi. Shox parda sathidagi yot jismni faqat shifokor oladi. Shifokor uni og‘riqsizlantirishdan keyin tirqishli lampa ostida maxsus igna yoki nayza yordamida olib tashlaydi. Temir zarrachasi atrofida zang halqasi bo‘lishi mumkin, u ham tozalanadi. Hamshira jihozlarni tayyorlaydi va bemorni ushlab turishga yordam beradi.

Yot jismni olish uchun tayyorgarlik va yordam

Jihozlar: anestetik tomchi, flyuoressein, steril tampon, fiziologik eritma, yot jism nayzasi yoki igna, lupa, antibiotikli tomchi va malham, steril salfetka

1. Bemorni qulay joylashtiring, ko‘rish o‘tkirligini aniqlang va yozing.
2. Shifokor ko‘rsatmasi bilan anestetik tomchi tomizing.
3. Steril stolni tayyorlang va asboblarni shifokorga bering.

4. Bemorga boshini qimirlatmaslik va bir nuqtaga qarashni ayting.
5. Muolajadan keyin flyuoressein bilan nuqson tekshiriladi.
6. Antibiotikli tomchi yoki malham qo‘ying, kerak bo‘lsa, bog‘lam qo‘yiladi.
7. Bemorga ertasi kuni qayta kelishni tushuntiring.

Flyuoressein sinamasi

Flyuoressein shox parda epiteliysi nuqsonini ko‘rsatadi. Bir tomchi eritma kon’yunktiva bo‘shlig‘iga tomiziladi yoki maxsus qog‘oz chiziq tegiziladi, ortiqchasi fiziologik eritma bilan yuviladi. Shikastlangan soha yashil rangga bo‘yaladi. Bu sinama shox parda eroziyasi, keratit va yot jismdan keyingi holatni baholash uchun ishlatiladi.

Ogohlantirish

- Ko‘zdagi yot jismni sterilmas narsa, ro‘mol yoki til bilan olish man etiladi.
- Ko‘z olmasi ichiga kirib ketgan yot jismga shubha bo‘lsa, uni olishga urinilmaydi, ko‘z bosilmaydi va bemor shoshilinch shifoxonaga yuboriladi.
- Metall bilan ishlovchilar himoya ko‘zoynagi taqishi kerak.
- Yot jism olingandan keyin og‘riq kuchaysa yoki ko‘rish pasaysa, darhol shifokorga murojaat qilinadi.

Yot jism olingandan keyin bemorga ko‘z bir necha soat achishishi mumkinligi aytiladi. U buyurilgan tomchilarni 3–5 kun tomizadi, ko‘zni ishqalamaydi va ertasi kuni ko‘rikka keladi.

2. Irit, iridotsiklit, uveitli bemorlarda tekshirish va birinchi yordam

Tomirli parda kasalliklari bilan og‘rigan bemorni tekshirishda hamshira shikoyatlarni aniqlaydi va ko‘rish funksiyalarini baholaydi. Bunday bemorlarda yorug‘likdan qo‘rqish kuchli bo‘lgani uchun ko‘rish o‘tkirligini aniqlashda sabr va ehtiyotkorlik kerak. Bemor og‘riq sababli ko‘zini to‘liq ocholmasligi mumkin, shuning uchun unga vaqt beriladi. Hamshira tekshiruvni avval sog‘lom ko‘zdan boshlaydi, natijani har ikki ko‘z uchun yozadi va uni oldingi ko‘rsatkichlar bilan solishtiradi.

Iridotsiklitli bemorda ko‘rish o‘tkirligini tekshirish

Jihozlar: Sivtsev–Golovin jadvali, Rot apparati, to‘siq, ko‘rsatgich

1. Bemorga tekshiruvni tushuntiring, yorug‘likdan qo‘rqsa, qisqa tanaffus bering.
2. Bemorni 5 m masofaga o‘tqazing, ko‘zoynagi bo‘lsa, taqtiring.
3. Sog‘lom ko‘zni birinchi tekshiring.
4. Kasal ko‘zni tekshiring, ko‘zni qattiq qismasligini kuzating.
5. Natijani yozing, oldingi natija bilan solishtiring.
6. Keskin pasayish bo‘lsa, darhol shifokorga xabar bering.

Bemorda nimalar kuzatiladi

Hamshira kunduzgi yorug‘likda ikki ko‘zni solishtiradi: perikorneal qizarish, rangdor parda rangi, qorachiq kattaligi va shakli. Iridotsiklitda kasal ko‘z qorachig‘i sog‘lom ko‘znikidan tor bo‘ladi, yorug‘likka sust javob beradi. Kiprikli tana sohasini yopiq qovoq ustidan yengil bosganda og‘riq kuchayadi. Ko‘z ichi bosimini palpator aniqlaganda, bosim normal yoki past bo‘ladi. Bu belgilar shifokorga xabar berish uchun yetarli. Hamshira o‘zi dori tanlamaydi, lekin qizil ko‘z bilan kelgan bemorning og‘ir holatini tanib olishi kerak.

O‘tkir iridotsiklitda birinchi yordam

Birinchi yordam og‘riqni kamaytirish, yopishishlarning oldini olish va yallig‘lanishni pasaytirishga qaratilgan bo‘lib, shifokor ko‘rsatmasi asosida bajariladi. Eng muhim chora qorachiqni kengaytirishdir, chunki u rangdor pardaning gavharga yopishishiga yo‘l qo‘ymaydi va kiprikli muskulni bo‘shashtirib, og‘riqni kamaytiradi. Tomizishdan oldin ko‘z ichi bosimi oshganiga shubha bo‘lmasligi kerak, shuning uchun bu muolaja shifokor ko‘rigidan keyin qilinadi.

O‘tkir iridotsiklitda birinchi yordam

Jihozlar: buyurilgan midriatik (1% atropin yoki boshqa), antibiotik va yallig‘lanishga qarshi tomchilar, himoya ko‘zoynagi

1. Bemorni tinchlantiring, shifokorga xabar bering.
2. Ko‘rish o‘tkirligi, harorat va qon bosimini aniqlang.
3. Shifokor ko‘rsatmasi bilan midriatik tomizing.
4. Atropin tomizgach, ichki burchakni 2–3 daqiqa bosib turing.
5. Yallig‘lanishga qarshi va antibiotik tomchilarni belgilangan tartibda tomizing.
6. Himoya ko‘zoynagi taqtiring, xonani qorong‘iroq qiling.
7. Bemorni ko‘z bo‘limiga kuzatib boring, hujjatni to‘ldiring.

Atropin glaukomada man etiladi. Atropin bolalarga va keksalarga ehtiyotkorlik bilan tomiziladi: og‘iz qurishi, yuz qizarishi, yurak urishi tezlashishi va hayajonlanish zaharlanish belgilari bo‘lib, bunday holatda dori to‘xtatiladi va shifokorga xabar beriladi. Bemor tomchidan keyin 1–2 hafta yaqinni yomon ko‘rishi haqida ogohlantiriladi, u mashina haydamasligi kerak.

Muntazam parvarish

Statsionarda hamshira kuniga bir necha marta tomchilarni tomizadi, in’yeksiyalarni bajaradi va kasallik dinamikasini kuzatadi. Bemor umumiy tekshiruvga tayyorlanadi: qon, siydik, rentgen, tish shifokori va LOR ko‘rigi, zarur bo‘lsa, sil va boshqa infeksiyalarga tahlillar. Kasallik qaytalanishining oldini olish uchun sovqotmaslik, infeksiya o‘choqlarini davolash va shifokor nazoratida bo‘lish tushuntiriladi.

Hamshira kuzatuv varag‘iga har kuni ko‘rish o‘tkirligi, qorachiq kengligi, og‘riq darajasi va qizarish o‘zgarishini yozadi. Qorachiq kengaymasa yoki noto‘g‘ri shaklda bo‘lsa, bu sinexiya belgisi bo‘lib, shifokorga darhol ma’lum qilinadi. Tana

harorati ko‘tarilishi, kuchli bosh og‘rig‘i va ko‘ngil aynishi ham alohida qayd etiladi, chunki ular asoratdan darak berishi mumkin.

3. Ko‘z tubini tekshirish va to‘r parda, ko‘ruv nervi kasalliklarida parvarish

Ko‘z tubini tekshirish oftalmoskopiya deb ataladi va uni shifokor bajaradi. Hamshira qorong‘i xonani, oftalmoskopni, lupani tayyorlaydi, bemorni to‘g‘ri joylashtiradi va zarur bo‘lsa, qorachiqni kengaytiruvchi tomchilarni tomizadi. Normal ko‘z tubida ko‘ruv nervi diski oq-pushti, chegaralari aniq, tomirlar normal, sariq dog‘ sohasi to‘q rangda ko‘rinadi.

Bemorni ko‘z tubini tekshirishga tayyorlash

Jihozlar: oftalmoskop, +13 D lupa, stol lampasi, midriatik tomchilar (shifokor buyrug‘i bilan)

1. Bemorda glaukoma, ko‘z ichi bosimi oshishi, dori allergiyasi haqida so‘rang.
2. Ko‘rish o‘tkirligini tekshirib, yozib qo‘ying.
3. Shifokor ko‘rsatmasi bilan qorachiqni kengaytiruvchi tomchini tomizing, ichki burchakni bosib turing.
4. 15–20 daqiqa kuting, bemorni o‘tirgan holda kuzating.
5. Qorong‘i xonada bemorni shifokor qarshisiga o‘tqazing.
6. Bemorga bir nuqtaga qarashni tushuntiring.
7. Tekshiruvdan keyin ko‘rish vaqtincha xiralashishi, yorug‘likdan qo‘rqish bir necha soat davom etishini ayting, haydashni cheklang.

Qorachiq kengaytirish qoidalari

Midriatik tomizishdan oldin ko‘z ichi bosimi o‘lchanadi. Oldingi kamera sayoz bo‘lsa, shifokor qisqa ta’sirli midriatik tanlaydi, chunki keng qorachiq kamera burchagini yopib, glaukoma xurujini keltirib chiqarishi mumkin. Tekshiruvdan keyin bemorda kuchli ko‘z og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, rangli halqalar ko‘rish paydo bo‘lsa, darhol shifokorga murojaat qilish tushuntiriladi.

To‘r parda kasalliklarida parvarish

Diabetik retinopatiyada hamshira bemorni lazer koagulyatsiyasiga tayyorlaydi: qon qandi va bosimi nazorat qilinadi, qorachiq kengaytiriladi, muolaja haqida tushuntiriladi. Lazerdan keyin bemor ko‘z oldida vaqtincha xiralik his qilishi mumkin, u og‘ir yuk ko‘tarmaydi va belgilangan vaqtda kuzatuvga keladi. To‘r parda ko‘chishiga shubha bo‘lganda bemor imkon qadar tinch holatda, yotgan yoki yarim yotgan vaziyatda shoshilinch tashiladi. Operatsiyadan keyin shifokor belgilagan bosh holatiga rioya qilish muhim, ayniqsa ko‘z ichiga gaz yuborilgan bo‘lsa, bemor samolyotda uchmasligi kerak.

Ko‘ruv nervi kasalliklarida parvarish

Nevritli bemor nevrolog bilan birga kuzatiladi. Ko‘rish o‘tkirligi va ko‘ruv maydoni muntazam tekshiriladi. Hamshira shifokor buyurgan tomir ichi va mushak ichi muolajalarni bajaradi, gormonal davo olayotgan bemorda qon bosimi, qand va oshqozon holatini kuzatadi. Ko‘rishi keskin pasaygan bemor palatada yolg‘iz qoldirilmaydi, unga ovqatlanish, yuvinish va harakatda yordam beriladi.

Past ko‘ruvchi bemorlar bilan ishlash

Ko‘rish qaytmas pasaygan bemorlarga reabilitatsiya imkoniyatlari tushuntiriladi: kattalashtiruvchi lupalar, katta shriftli materiallar, ovozli qurilmalar va ijtimoiy yordam. Bemorga ruhiy dalda berish, uni oilasi va jamiyatdan ajratmaslik muhim. Hamshira yaqinlarini bemorga yordam ko‘rsatishga o‘rgatadi, uyda xavfsizlik choralarini tushuntiradi: yo‘lakda buyumlar qoldirmaslik, yorug‘likni yaxshilash, buyumlarni doimiy joyda saqlash.

Barcha muolajalar hujjatda qayd etiladi. Amaliy mashg‘ulot davomida o‘quvchilar bu ko‘nikmalarni mulyajda va bir-birida xavfsiz tarzda mashq qiladi, dori tomizish esa faqat mulyajda bajariladi. Mashg‘ulot yakunida o‘qituvchi yo‘riqli texnologik xarita asosida har bir o‘quvchining ko‘nikmasini baholaydi va xatolarni tahlil qiladi.

Ko‘z tubini suratga olish va OKT

Hozirda ko‘p markazlarda fundus-kamera va optik kogerent tomografiya ishlatiladi. Bemor iyak tayanchiga joylashadi, bir nuqtaga qaraydi, qisqa chaqnash bo‘lishi mumkinligi oldindan aytiladi. Tekshiruv og‘riqsiz, bir necha daqiqa davom etadi. Hamshira tayanchlarni dezinfeksiya qiladi, bemor ma’lumotlarini kiritadi va natijalarni shifokorga yetkazadi. Diabetli bemorlarda ko‘z tubi suratlari taqqoslash uchun saqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.